

Интерстициальный цистит / синдром болевого мочевого пузыря WARWIKI

Информация для пациента · Хроническая боль и позывы без инфекции

Интерстициальный цистит, или синдром болевого мочевого пузыря (IC/BPS), — это хроническое состояние с **болью, давлением или дискомфортом** в мочевом пузыре или малом тазу, а также учащёнными или urgentными позывами — **без инфекции**. Дискомфорт нарастает при наполнении пузыря и уменьшается после мочеиспускания. Состояние поддаётся лечению, хотя единого метода излечения нет.

Об этом состоянии

IC/BPS — не инфекция и не заразно. Симптомы варьируют у разных людей и протекают **вспышками** (периоды ухудшения) с более спокойными промежутками. Типичные признаки:

- Боль, давление или дискомфорт в мочевом пузыре или малом тазу
- Частые и/или urgentные позывы, днём и ночью
- Дискомфорт, **усиливающийся при наполнении пузыря** и стихающий после мочеиспускания
- Вспышки, провоцируемые определёнными продуктами, стрессом или менструальным циклом

Причины

Точная причина неизвестна. Вероятно, сочетание раздражённой слизистой мочевого пузыря, гиперчувствительных нервов и (нередко) **напряжённого тазового дна**. Из-за нескольких механизмов лечение обычно включает несколько подходов.

ТЕРМИНЫ

IC/BPS

Интерстициальный цистит / синдром болевого мочевого пузыря — боль и позывы без инфекции.

Вспышка

Период ухудшения симптомов, часто связанный с едой или стрессом.

Диагноз исключения

Ставится после исключения других причин (например, инфекции).

Физиотерапия тазового дна

Расслабление напряжённых мышц таза.

Инстиляция мочевого пузыря

Введение успокаивающего препарата через катетер.

Поражение Hunner

Специфический участок стенки пузыря у части пациентов, поддающийся прямому лечению.

Цистоскопия

Осмотр мочевого пузыря тонкой камерой.

ПРОЙДЁТ ЛИ ЭТО? IC/BPS обычно является хроническим состоянием, но большинство пациентов достигают значительного улучшения, сочетая методы лечения и выявляя триггеры. Цель — реже и легче переносить вспышки, вести нормальную жизнь. Подбор лечения требует времени — будьте терпеливы.

Как это диагностируют

Единого теста нет. Диагноз ставится на основании симптомов после исключения других причин:

- **Анализ мочи** для исключения инфекции или крови
- Анамнез симптомов и **дневник мочеиспускания**
- В ряде случаев — **цистоскопия** для выявления поражения Hunner

Как это лечат (поэтапно)

- 1 **Самопомощь** — выявите **пищевые триггеры**, управляйте стрессом и сном, используйте мягкую тренировку мочевого пузыря.
- 2 **Физиотерапия тазового дна** — расслабление напряжённых мышц (усиленные упражнения Кегеля могут ухудшить состояние).
- 3 **Лекарства** — таблетки и успокаивающие **инстилляции** в мочевой пузырь.
- 4 **Прицельное и расширенное лечение** — терапия поражения Hunner или нейростимуляция в стойких случаях.

Жизнь с IC/BPS

- Частые триггеры: **кофе, чай, алкоголь, цитрусовые, томаты, острые блюда** — исключайте по одному, чтобы выявить свои.
- Составьте **план действий при вспышке** (отдых, тепло, дополнительное питьё, нейтральная пища).
- Стресс и напряжённое тазовое дно поддерживают цикл — мягкая активность и расслабление помогают.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры, озноб или боль в спине/боку (возможная инфекция)
- Впервые появившаяся **кровь в моче**
- Вспышка, не поддающаяся контролю, или невозможность помочиться

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. IC/BPS — боль и позывы **без** инфекции: хроническое, но хорошо поддающееся лечению состояние.
2. Лечение сочетает самопомощь и контроль триггеров, физиотерапию, лекарства, инстилляции и прицельные методы.
3. Ведите дневник триггеров и имейте план действий при вспышке. Кровь в моче, температура или боль в боку требуют осмотра.